

BRAIN CARE
SERIES

หมออดิศักดิ์
รักษ์สมอง



เล่มที่ 1



พ่อแม่ขี้ลืม ปกติหรืออัลไซเมอร์?

คู่มือเข้าใจความจำ สมองเสื่อม และการดูแลคนที่เรารัก

นพ.อดิศักดิ์ กิตติสารศร

อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา

สารบัญ

เดินทางเข้าใจสมอง — ทีละบท

บ

บทนำ — วันที่ลูกเริ่มรู้สึกที่พ่อแม่เปลี่ยนไป

"ความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ อาจไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุด สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการไม่เข้าใจ"

1

ความขี้ลืมที่เกิดขึ้นกับทุกคน

"สมองอาจใช้เวลาค้นหาความทรงจำนานขึ้น แต่ไม่ได้แปลว่ามันหายไป"

2

ความขี้ลืมตามวัย กับ อัลไซเมอร์ ต่างกันอย่างไร

"คำถามไม่ใช่ว่าวันนี้ท่านลืมอะไร — แต่คือความหลงลืมนั้นกำลังเปลี่ยนชีวิตหรือไม่"

3

10 สัญญาณเตือนอัลไซเมอร์ที่ไม่ควรมองข้าม

"อัลไซเมอร์มักกระซิบผ่านเหตุการณ์เล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน"

4

ระหว่างปกติกับอัลไซเมอร์ — เมื่อสมองส่งสัญญาณ

"สัญญาณเตือนไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เรากลัว แต่เพื่อให้เรายังมีเวลาเริ่มดูแล"

5

ความจำแย่ ไม่ได้แปลว่าเป็นอัลไซเมอร์เสมอไป

"ก่อนถามว่านี่คืออัลไซเมอร์หรือไม่ — บางครั้งคำถามที่สำคัญกว่าคือเกิดอะไรขึ้นกับสมอง"

6

ถ้าสงสัยพ่อแม่มีปัญหาความจำ ควรตรวจอะไรบ้าง

"การตรวจความจำคือการฟังว่าสมองกำลังต้องการความช่วยเหลือแบบไหน"

7

ถ้าเป็นอัลไซเมอร์จริง เรายังทำอะไรได้บ้าง

"อัลไซเมอร์อาจทำให้ความทรงจำเลือนหาย แต่ไม่ได้ทำให้คุณค่าของชีวิตลดลง"

8

7 เคล็ดลับดูแลสมอง ลดความเสี่ยงสมองเสื่อม

"สมองที่ดีในวันข้างหน้า เกิดจากสิ่งเล็ก ๆ ที่เราทำซ้ำในทุกวัน"

9

เมื่อพ่อแม่เริ่มหลงลืม ลูกหลานควรดูแลอย่างไร

"เราชวนพ่อแม่จำ ไม่ใช่เพื่อดูว่าท่านลืม แต่เพื่อให้ท่านได้สัมผัสว่าชีวิตของท่านงดงามเพียงใด"



Brain Care Toolkit

แบบประเมิน — บทสนทนา — รายการตรวจ — เคล็ดลับดูแลสุขภาพ



ส่งท้ายจากหมอ

"ความทรงจำอาจเปลี่ยนไป... แต่ความรักยังคงอยู่"



เกี่ยวกับผู้เขียน

นพ.อดิศักดิ์ กิตติสารเลิศ — อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา

วันที่ลูกเริ่มรู้สึกว่า พ่อแม่เปลี่ยนไป



บางครั้ง จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ไม่ได้เริ่มจากผลตรวจสมอง ไม่ได้เริ่มจากการวินิจฉัยโรค แต่เริ่มจาก เหตุการณ์เล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นเงียบ ๆ ภายในบ้าน

อาจเป็นวันที่แม่ถามคำถามเดิมเป็นครั้งที่สามในช่วงเช้า อาจเป็น วันที่พ่อโทรมาถามเส้นทางกลับบ้าน ทั้งที่เป็นเส้นทางที่ขบมาเกือบยี่สิบปี หรืออาจเป็นเพียงความรู้สึกบางอย่างที่ลูกหลานอธิบายไม่ถูก — ความรู้สึกที่บอกว่า "พ่อแม่ยังเป็นคนเดิม" แต่ในขณะเดียวกัน "บางอย่างดูไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว"

ในห้องตรวจของหมอ มีลูกหลานจำนวนไม่น้อยที่เริ่มต้น
บทสนทนาด้วยคำพูดคล้าย ๆ กัน พวกเขาไม่ได้พูดว่าแม่จำอะไรไม่ได้
ไม่ได้พูดว่าพ่อเป็นอัลไซเมอร์ แต่พูดเพียงว่า

"หมอครับ ช่วงหลัง ๆ แม่ดูเปลี่ยนไป"
หรือ "หมอคะ หนูไม่แน่ใจว่าคิดมากไปเองหรือเปล่า"

หลายครั้ง ความกังวลไม่ได้เกิดจากอาการที่ชัดเจน แต่เกิดจากการ
ที่คนในครอบครัวรู้จักกันดีเกินกว่าจะมองข้ามความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ
เหล่านั้นได้ ลูกอาจเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นว่าแม่เริ่มเล่าเรื่องเดิมซ้ำ
ภรรยาอาจเป็นคนแรกที่รู้ว่าสามีเริ่มลืมเรื่องที่เพิ่งคุยกันเมื่อวาน หรือ
หลานอาจเป็นคนแรกที่พบว่าคุณตาเริ่มสับสนกับสิ่งที่เคยทำเป็น
ประจำ

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว แต่ค่อย ๆ
ปรากฏขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ราวกับเงาที่ค่อย ๆ เคลื่อนผ่านกำแพงใน
ยามบ่าย จนกระทั่งวันหนึ่งใครบางคนในครอบครัวเริ่มถามคำถามที่ไม่
มีใครอยากถาม

**"นี่เป็นเรื่องปกติของอายุที่มากขึ้น
หรือกำลังเป็นสัญญาณของโรคอัลไซเมอร์กันแน่"**

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม หมอพบว่าคำถามนี้เป็นหนึ่งในคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตของหลายครอบครัว เพราะคำตอบของมันไม่ได้ส่งผลต่อผู้ป่วยเพียงคนเดียว แต่ส่งผลต่อทั้งคนที่รักเขา ลูกหลานที่ดูแลเขา และอนาคตที่ทุกคนกำลังจะเดินไปด้วยกัน

อัลไซเมอร์เป็นโรคที่ผู้คนรู้จักชื่อกันดี แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโรคที่เต็มไปด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อน หลายคนเชื่อว่าความขี้ลืมทุกอย่างคืออัลไซเมอร์ ขณะที่อีกหลายคนกลับคิดว่าความขี้ลืมทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องธรรมดาของคนแก่ **ความจริงอยู่ตรงกลางระหว่างสองสิ่งนั้น**

เมื่ออายุมากขึ้น สมองของเราย่อมเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับสายตา กล้ามเนื้อ หรือการทรงตัว ความจำอาจไม่เฉียบคมเหมือนเดิม การนึกชื่อคนอาจใช้เวลานานขึ้น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับคนจำนวนมาก และไม่ได้หมายความว่า เป็นโรคสมองไป แต่อีกด้านหนึ่งโรคอัลไซเมอร์ก็มักเริ่มต้นอย่างเงียบเช่นกัน เงียบเสียจนหลายครอบครัวไม่แน่ใจว่าควรเริ่มกังวลเมื่อใด

นั่นคือเหตุผลที่หมอเขียนหนังสือเล่มนี้ — ไม่ใช่เพื่อให้ทุกคนหวาดกลัวโรคอัลไซเมอร์ แต่เพื่อให้เข้าใจมัน ไม่ใช่เพื่อให้มองพ่อแม่ด้วยความระแวง แต่เพื่อให้มองด้วยความเข้าใจมากขึ้น และไม่ใช่เพื่อให้รีบสรุปว่าเป็นโรค แต่เพื่อให้รู้ว่าเมื่อใดควรสังเกต เมื่อใดควรปรึกษาแพทย์ และเมื่อใดควรลงมือดูแลสุขภาพสมองอย่างจริงจัง

● หมอชวนคิด

หลายครั้ง สิ่งแรกที่อัลไซเมอร์พรากไปจากครอบครัว ไม่ใช่ความทรงจำ แต่คือความมั่นใจว่า "ทุกอย่างยังเหมือนเดิม"

และหลายครั้งเช่นกัน การดูแลที่ดีที่สุดไม่ได้เริ่มต้นจากยา แต่มักเริ่มต้นจากการสังเกต ความเข้าใจ และความรักของคนในครอบครัว

หากท่านกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ ไม่ว่าจะด้วยความกังวล ความสงสัย หรือเพียงความตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพสมองให้ดีขึ้นในอนาคต หมอขอต้อนรับสู่การเดินทางครั้งนี้

**การเดินทางเพื่อทำความเข้าใจสมอง
และทำความเข้าใจคนที่เรารัก
ให้ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิม**

พว.อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ

อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา

ความขี้ลืม ที่เกิดขึ้นกับทุกคน



คุณสมชายอายุ 68 ปี เป็นอดีตผู้บริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ตลอดชีวิตการทำงาน เขาเป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความจำดี จำเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าได้หลายสิบคนโดยไม่ต้องเปิดสมุดบันทึก จำกำหนดประชุมสำคัญได้โดยแทบไม่ต้องจด และสามารถเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนได้อย่างละเอียด

วันหนึ่งหลังเกษียณ เขาเดินขึ้นไปชั้นสองของบ้านเพื่อหยิบเอกสารบางอย่าง แต่เมื่อเดินไปถึง กลับจำไม่ได้ว่าตนเองขึ้นมาทำอะไร เขายืนอยู่หน้าห้องทำงานครู่หนึ่ง ก่อนจะหัวเราะกับตัวเองเบา ๆ แล้วเดินกลับลงไปชั้นล่าง เมื่อกลับมาถึงห้องนั่งเล่น เขาก็จึงนึกออกทันทีว่า กำลังจะขึ้นไปหยิบเอกสารอะไร

หลายคนคงเคยมีประสบการณ์ลักษณะนี้ — บางครั้งเราเดินเข้าห้องแล้วลืมว่ามาทำอะไร บางครั้งจำชื่อคนที่รู้จักดีไม่ออกชั่วขณะ บางครั้งหากญแจบ้านไม่เจอทั้งที่วางอยู่ตรงหน้า หรือบางครั้งเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วจำไม่ได้ว่ากำลังจะค้นหาอะไร

เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับคนอายุน้อย เรามักหัวเราะแล้วปล่อยผ่าน แต่เมื่อเกิดขึ้นกับพ่อแม่ที่อายุเจ็ดสิบหรือแปดสิบปี หลายครอบครัวเริ่มกังวลทันที คำถามที่เกิดขึ้นในใจคือ *"นี่เป็นความขี้ลืมธรรมดา หรือกำลังเริ่มเป็นอัลไซเมอร์"*

สมองเปลี่ยนตามวัย เป็นเรื่องธรรมชาติ

ความจริงข้อแรกที่ हमอยากให้คุณทันทราบก็คือ ความขี้ลืมบางอย่างเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสมอง เช่นเดียวกับที่สายตาอาจพร่ามัวลงเมื่ออายุมากขึ้น หรือกล้ามเนื้ออาจไม่แข็งแรงเหมือนเดิม การดึงข้อมูลจากคลังความทรงจำอาจใช้เวลานานขึ้น การเรียนรู้สิ่งใหม่อาจต้องใช้การทบทวนมากขึ้น และความเร็วในการประมวลผลข้อมูลอาจลดลงเล็กน้อย

แต่สิ่งสำคัญคือ แม้สมองจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย คนส่วนใหญ่ยังคงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ พวกเขายังคงดูแลตนเองได้ ยังคงบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตได้ และยังคงมีความสามารถในการตัดสินใจเช่นเดิม



ห้องสมุดในสมอง

การเปลี่ยนแปลงของความจำตามวัยเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ยังมีหนังสือครบทุกเล่ม แต่บรรณารักษ์ใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยในการค้นหาหนังสือที่ต้องการ — หนังสือยังอยู่ ข้อมูลยังอยู่ เพียงแต่ต้องใช้เวลาค้นหามากขึ้น

ในทางตรงกันข้าม โรคอัลไซเมอร์ไม่ใช่เพียงการค้นหาข้อมูลช้าลง แต่เป็นภาวะที่หนังสือบางเล่มเริ่มหายไปจากชั้นหนังสือที่ละเล่ม ในระยะแรกอาจหายไปเพียงไม่กี่เล่ม จนแทบไม่มีใครสังเกตเห็น แต่เมื่อเวลาผ่านไป หนังสือที่หายไปมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

ความแตกต่างสำคัญ คือระหว่าง "ความจำช้าลง" กับ "ความจำเสื่อม"

คนที่กังวล มักไม่ใช่คนที่ป่วย

หลายครั้งคนไข้ที่มีความวิตกกังวลตามวัยจะพูดกับหมอว่า "ช่วงนี้ความจำไม่ค่อยดีเลยครับ" สิ่งที่น่าสนใจคือ คนที่กังวลเรื่องความจำของตนเองมาก ๆ มักยังมีความสามารถในการรับรู้ปัญหาของตนเองได้ดี ในขณะที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะแรกจำนวนไม่น้อยกลับรู้สึกกว่าตนเองยังปกติดี แต่คนในครอบครัวเป็นผู้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง

หมอยังจำลูกสาวคนหนึ่งได้ดี เธอพาคุณแม่วัย 74 ปี มาพบหมอด้วยเหตุผลว่าแม่ถามคำถามเดิมซ้ำบ่อยขึ้น เมื่อหมอถามคุณแม่ว่า "คุณแม่รู้สึกว่าการจำเปลี่ยนไปบ้างไหมครับ" คุณแม่ตอบทันทีว่า "ไม่เห็นเป็นอะไรเลยค่ะ"

แต่ระหว่างการซักประวัติ ลูกสาวกลับเล่าว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แม่ถามเรื่องนัดพบญาติคนเดิมซ้ำหลายครั้งภายในวันเดียว และจำไม่ได้ว่าตนเองเพิ่งได้รับคำตอบไปแล้ว เหตุการณ์เช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า บางครั้งผู้ที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดที่สุด อาจไม่ใช่ตัวผู้ป่วย แต่เป็นคนที่อยู่ข้าง ๆ เขาในทุกวัน นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อมูลจากลูกหลานจึงมีความสำคัญอย่างมากในการประเมินความจำ

อย่ารีบสรุปว่าเป็นอัลไซเมอร์

หมออยากให้ทุกท่านระมัดระวังอีกด้านหนึ่งเช่นกัน — ไม่ใช่ความขี้ลืมทุกอย่างจะเกิดจากอัลไซเมอร์ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า การนอนหลับไม่เพียงพอ ความวิตกกังวล หรือแม้แต่ความเหนื่อยล้าสะสม ล้วนสามารถทำให้ความจำแย่ลงได้ชั่วคราว ในบางกรณี เมื่อรักษาสาเหตุเหล่านี้ ความจำก็กลับมาดีขึ้นได้อย่างชัดเจน

ดังนั้น เมื่อเริ่มสังเกตเห็นความหลงลืมในตัวพ่อแม่หรือคนที่เรารัก สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การรีบสรุปว่าเป็นอัลไซเมอร์ แต่คือการสังเกตอย่างเป็นระบบ — ความหลงลืมนั้นเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด มีแนวโน้มมากขึ้นหรือไม่ และเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหรือยัง เพราะในท้าย

ที่สุดแล้ว สิ่งที่แพทย์ให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงว่าผู้ป่วยลิ้มหรือไม่ลิ้ม แต่คือความหลงใหลนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาหรือไม่

● หมอชวนคิด

เมื่อพ่อแม่อายุมากขึ้น หลายครอบครัวเฝ้าสังเกตว่าท่าน "ลิ้มอะไร" แต่บางครั้งคำถามที่สำคัญกว่า คือ "ท่านยังใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมหรือไม่"

เพราะอัลไซเมอร์ไม่ได้วัดจากจำนวนครั้งที่ลิ้ม แต่วัดจากผลกระทบที่ความหลงใหลนั้นมีต่อชีวิตของคนคนหนึ่ง

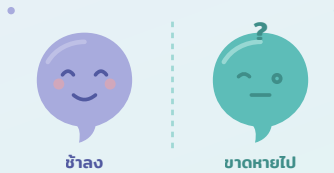
● สิ่งที่เหมาะสมอยากให้จำ

ความซึ่ลิ้มตามวัย คือการจำได้ช้าลง

อัลไซเมอร์ คือการเริ่มสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตจากปัญหาด้านความจำ

ความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้ คือหัวใจสำคัญของหนังสือทั้งเล่ม และเป็นสิ่งที่หมอจะชวนท่านทำความเข้าใจต่อไป

ความขี้ลืมตามวัย กับ อัลไซเมอร์ ต่างกันอย่างไร



มีประโยคหนึ่งที่หมอได้ยินอยู่เสมอในห้องตรวจ "หมอครับ พ่อก็แค่ขี้ลืมตามอายุใช่ไหม" หรือบางครั้งก็เป็นคำถามในอีกด้านหนึ่ง "หมอคะ แม่ลืมแบบนี้ แปลว่าเป็นอัลไซเมอร์แล้วหรือเปล่า"

ความจริงแล้ว คำถามทั้งสองข้อไม่ได้มีคำตอบง่าย ๆ แบบใช่หรือไม่ใช่ เพราะระหว่าง "ปกติ" กับ "อัลไซเมอร์" มีพื้นที่ตรงกลางที่กว้างกว่าที่หลายคนคิด

เรื่องเล่าจากห้องตรวจ

คุณป้าศรี อายุ 71 ปี อดีตครูเกษียณ ช่วงหลังเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจำชื่อคนได้ช้าลง บางครั้งนึกคำพูดไม่ออกในทันที และบางวันก็ลืมว่าตนเองวางแว่นตาไว้ตรงไหน เรื่องเหล่านี้ทำให้เธอหงุดหงิดไม่น้อย แต่

เมื่อใช้เวลาสักพัก เธอก็มักนึกออกในที่สุด เธอยังคงอ่านหนังสือทุกวัน ดูแลบัญชีธนาคารด้วยตนเอง และเดินทางไปพบเพื่อนเป็นประจำ

คุณลุงประสิทธิ์ อายุ 73 ปี ลูกชายเริ่มสังเกตว่าพ่อถามเรื่องเดิมซ้ำหลายครั้งภายในวันเดียว เมื่อได้รับคำตอบแล้ว เพียงไม่กี่นาทีต่อมา ก็กลับมาถามใหม่อีกครั้ง ช่วงหลังเริ่มจำยิบผิด ลืมวันนัดสำคัญ และเคยขับรถเลยทางเข้าบ้านของตนเอง ทั้งที่อาศัยอยู่ที่นั่นมานานกว่าสิบปี เมื่อหมอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น คุณลุงตอบอย่างมั่นใจว่า *"ผมก็ปกติดีนะ"*

ความแตกต่างระหว่างคนสองคนนี้ ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครลืมมากกว่ากัน แต่อยู่ที่ *"ลักษณะของความหลงลืม"* และ *"ผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน"*

ค้นหาว่า กับ ไม่ได้เก็บไว้ตั้งแต่แรก

คนที่มีความจำเปลี่ยนแปลงตามวัย มักยังเก็บข้อมูลไว้ได้ครบ เพียงแต่เรียกข้อมูลออกมาได้ช้าลง พวกเขาอาจนึกชื่อคนไม่ออกในทันที แต่สุดท้ายก็นึกออก อาจลืมนำกุญแจวางอยู่ตรงไหน แต่เมื่อย้อนคิดก็จำได้ อาจต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ แต่ยังสามารถเรียนรู้ได้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ความทรงจำยังอยู่ เพียงแต่สมองต้องใช้เวลาค้นหามานานขึ้น

ในทางตรงกันข้าม ผู้ป่วยอัลไซเมอร์มักไม่ได้มีปัญหาเพียงเรื่องการค้นหาข้อมูล แต่มีปัญหาในการเก็บข้อมูลใหม่ตั้งแต่แรก เหตุการณ์ที่

เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเข้าอาจไม่ถูกบันทึกเข้าสู่ความทรงจำอย่างสมบูรณ์ เมื่อไม่มีข้อมูลถูกเก็บไว้ ก็ไม่มีสิ่งใดให้ค้นหาในภายหลัง

นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะแรกจึงมักถามคำถามเดิมซ้ำ ๆ ไม่ใช่เพราะดื้อ ไม่ใช่เพราะไม่ตั้งใจฟัง แต่เพราะสมองไม่ได้เก็บข้อมูลการสนทนาครั้งก่อนเอาไว้อย่างสมบูรณ์



เปรียบกับการถ่ายรูป

ความขี้ลืมตามวัย = มีรูปภาพอยู่ในเครื่อง แต่หาไม่เจอในทันที
อัลไซเมอร์ = รูปภาพนั้นไม่เคยถูกบันทึกลงในเครื่องตั้งแต่แรก
แม้จะพยายามค้นหาเพียงใด ก็ไม่สามารถหารูปที่ไม่มีอยู่ได้

ในชีวิตจริง สิ่งที่ถูกหลานมักสังเกตเห็นก่อนมักไม่ใช่คะแนนการทดสอบความจำ แต่เป็นความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน — แม้ที่เคยทำอาหารสูตรเดิมมาทั้งชีวิต เริ่มลืมขั้นตอนบางอย่าง พ่อที่เคยบริหารการเงินของครอบครัวได้ดี เริ่มสับสนเรื่องตัวเลข คุณตาที่เคยเล่าเรื่องเก่า ๆ ได้อย่างสนุกสนาน เริ่มจำไม่ได้ว่าหลานมาเยี่ยมเมื่อวาน

หลายครั้ง สัญญาณเหล่านี้มีความหมายมากกว่าการลืมชื่อคนเพียงอย่างเดียว เพราะมันสะท้อนว่าความหลงลืมกำลังเริ่มกระทบต่อการดำเนินชีวิต และนั่นคือจุดที่ควรให้ความสนใจ

● หมอชวนคิด

ลูกหลานจำนวนมากเริ่มกังวลเมื่อพ่อแม่ลืม แต่ในความเป็นจริง สิ่ง
ที่ควรสังเกตไม่ใช่เพียงว่า "ลืมหรือไม่" แต่คือ "หลังจากลืมแล้ว ชีวิต
ของท่านเปลี่ยนไปหรือไม่"

ความจำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมอง สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือความ
สามารถในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ

● สิ่งที่หมออยากให้อำ

ความขี้ลืมตามวัย — จำได้บ้าง / นึกออกภายหลัง / ยังใช้ชีวิตได้
ตามปกติ

อัลไซเมอร์ระยะแรก — ลืมข้อมูลใหม่ซ้ำ ๆ / ถ้ามเรื่องเดิมหลาย
ครั้ง / เริ่มกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

ความแตกต่างเล็ก ๆ นี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ครอบครัว
สังเกตโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

10 สัญญาณเตือน อัลไซเมอร์ที่ไม่ควรมองข้าม



หลายครั้งที่ลูกหลานพาพ่อแม่มาพบหมอ พวกเขา มักเริ่มต้นด้วยประโยคเดียวกัน "จริง ๆ แล้วหนูไม่แน่ใจว่าควรกังวลหรือเปล่า"

นั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เพราะอัลไซเมอร์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยภาพจำที่หลายคนคุ้นเคย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งแล้วจำใครไม่ได้ทันที โรคนี้มักค่อย ๆ ปรากฏตัวอย่างเงียบ ๆ ผ่านเหตุการณ์เล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เล็กเสียดจนบางครั้งคนในครอบครัวใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี กว่าที่จะเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นเข้าด้วยกัน

เมื่อมองย้อนกลับไป หลายครอบครัวมักพูดเหมือนกันว่า "สัญญาณมันมีอยู่แล้ว แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันสำคัญ"

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้ป่วยสมองเสื่อม หมอพบว่าสัญญาณเตือนที่พบบ่อยที่สุดมักมีอยู่สืบลักษณะต่อไปนี้ — ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมด และการมีเพียงข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้หมายความว่าป็นอัลไซเมอร์เสมอไป แต่หากเริ่มพบหลายข้อร่วมกัน หรือมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ควรได้รับการประเมินเพิ่มเติม

1

ถามคำถามเดิมซ้ำ ๆ

ลูกหลานมักเล่าว่าแม่ถามว่าพรุ่งนี้จะไปไหน หลังจากตอบไปแล้วไม่นานก็ถามคำถามเดิมอีกครั้ง สมองอาจเริ่มมีปัญหาในการเก็บข้อมูลใหม่ จึงทำให้บทสนทนาที่เพิ่งเกิดขึ้นเลือนหายไปอย่างรวดเร็ว

2

ลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น

ผู้ป่วยอาจจำเรื่องในอดีตเมื่อสามสัปดาห์ก่อนได้อย่างชัดเจน แต่กลับจำไม่ได้ว่าลูกมาเยี่ยมเมื่อวาน เพราะสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความทรงจำใหม่ มักได้รับผลกระทบก่อนส่วนอื่น

3

วางของผิดที่ผิดทาง

การวางรีโมตทีวีไว้ในตู้เย็น วางกระเป๋าใส่ตังค์ไว้ในถังขยะ หรือเก็บของไว้ในตำแหน่งที่ไม่สมเหตุสมผล อาจเป็นสิ่งที่ควรสังเกต ผู้ป่วยมักจำไม่ได้ว่าตนเองนำของไปวางไว้เมื่อใด

4

เริ่มสับสนเรื่องเวลา

พ่อเริ่มถามว่าวันนี้วันอะไรซ้ำหลายครั้ง บางคนสับสนระหว่างเช้ากับเย็น บางคนจำวันที่ เดือน หรือปีผิด เป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการรับรู้เริ่มเปลี่ยนแปลง

5

หลงทางในสถานที่คุ้นเคย

ผู้ป่วยอาจหลงทางในเส้นทางที่เคยใช้เป็นประจำมาหลายปี บางคนขับรถกลับบ้านไม่ถูก บางคนเดินออกจากบ้านแล้วจำทางกลับไม่ได้ เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรถูกมองข้าม

6

งานที่เคยทำได้ยากขึ้น

แม่ที่เคยทำอาหารได้คล่องแคล่ว อาจเริ่มลืมขั้นตอน พ่อที่เคยจัดการบัญชีครอบครัวได้ดี อาจเริ่มคำนวณผิดพลาด งานที่เคยเป็นเรื่องง่าย อาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อนขึ้น

7

หาคำพูดไม่เจอบ่อยขึ้น

ผู้ป่วยอาจเรียกสิ่งของผิดชื่อ หยุดกลางประโยคบ่อย ๆ หรือใช้คำอ้อมค้อมแทนคำที่นึกไม่ออกจนกระทบต่อการสื่อสาร

8

การตัดสินใจเปลี่ยนไป

บางคนเริ่มโอนเงินให้มิชชันนารีฟังกายขึ้น ซื้อของผิดปกติ ดูแลสุขอนามัยตนเองลดลงอย่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

9

เริ่มถอนตัวจากสังคม

คนที่เคยชอบพบปะเพื่อนฝูง อาจเริ่มไม่อยากออกจากบ้าน เลิกเข้าร่วมกิจกรรมที่เคยชอบ บางครั้งไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจ แต่เกิดจากความไม่มั่นใจในความสามารถของตนเอง

10

บุคลิกภาพหรืออารมณ์เปลี่ยนไป

คนใจเย็นอาจกลายเป็นคนหงุดหงิดง่าย คนมั่นใจอาจกลายเป็นคนหวาดระแวง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดขึ้นก่อนที่ความจำจะเสื่อมลงอย่างชัดเจนเสียอีก

เมื่อหมอมองย้อนกลับไปเป็นผู้ป่วยจำนวนมาก สิ่งที่น่าสนใจคือ ครอบครัวมักไม่ได้กังวลจากอาการเพียงข้อเดียว แต่เป็นเพราะหลายเหตุการณ์เล็ก ๆ เริ่มเกิดขึ้นพร้อมกัน — คำถามเดิมที่ถูกถามซ้ำ นัดหมายที่ถูกลืม เส้นทางที่เคยคุ้นเคยแต่กลับหลงทาง และความรู้สึกบางอย่างที่บอกว่า *"ท่านไม่เหมือนเดิม"*

● หมอชวนคิด

สัญญาณเตือนของอัลไซเมอร์มักไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่เพียงครั้งเดียว แต่มักเป็นเหตุการณ์เล็ก ๆ หลายเหตุการณ์ที่ค่อย ๆ ต่อกันเป็นภาพใหญ่

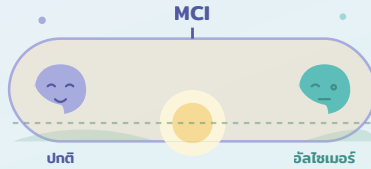
บางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดจึงไม่ใช่การสังเกตเพียงวันเดียว แต่คือการมองเห็นแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา

● สิ่งที่เหมาะสมให้จำ

หากเริ่มพบสัญญาณเตือนหลายข้อร่วมกัน หรือพบว่าความหลงลืมเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สิ่งที่เราควรทำไม่ใช่การรีบสรุปว่าเป็นอัลไซเมอร์ แต่คือการเข้ารับการประเมินอย่างเหมาะสม

เพราะโรคสมองเสื่อมไม่ใช่สาเหตุเดียวของความจำที่เปลี่ยนไป และหลายภาวะสามารถรักษาได้ หากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่น ๆ

ระหว่างปกติกับอัลไซเมอร์ เมื่อสมองเริ่มส่งสัญญาณ



มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ลูกหลานจำนวนมากรู้สึกสับสนที่สุด — ไม่ใช่วันที่พ่อแม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร์ แต่เป็นช่วงเวลาก่อนหน้านั้น ช่วงที่ทุกอย่างดูเหมือนจะยังปกติ แต่ก็ไม่ปกติเสียทีเดียว

หมอยังจำบทสนทนากับลูกชายคนหนึ่งได้ดี เขาพาคุณพ่อวัย 72 ปีมาพบหมอด้วยเหตุผลที่ฟังดูไม่ชัดเจนนัก "จริง ๆ พ่อก็ยังใช้ชีวิตได้ปกตินะครับ" เขาพูด "แต่ผมรู้สึกว่่าพ่อเปลี่ยนไป"

เมื่อหมอถามว่าหมายถึงอะไร เขานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบ "พ่อเริ่มลืมเรื่องที่เพิ่งคุยกัน บางครั้งถามเรื่องเดิมซ้ำ แต่ก็ยังขับรถได้ ยังจัดการชีวิตตัวเองได้" จากนั้นเขาถามคำถามที่ลูกหลานจำนวนมากอยากรู้ "แบบนี้ถือว่าเป็นอัลไซเมอร์แล้วหรือยังครับ"

คำตอบคือ "อาจจะใช่ หรืออาจจะยังไม่ใช่" เพราะในทางการแพทย์ ยังมีอีกภาวะหนึ่งที่อยู่ระหว่างความจำปกติกับโรคสมองเสื่อม ภาวะนั้นเรียกว่า **Mild Cognitive Impairment** หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า **MCI**

พื้นที่ตรงกลางที่หลายคนไม่เคยรู้จัก

ลองนึกถึงพระอาทิตย์กำลังตกดิน — ช่วงเวลาก่อนกลางคืนจะมาถึง ท้องฟ้าไม่ได้สว่างเหมือนตอนกลางวัน แต่ก็ยังไม่มีดสนิท

MCI ก็มีลักษณะคล้ายกัน — ไม่ใช่ภาวะปกติ แต่ยังไม่ใช่ภาวะสมองเสื่อมเต็มรูปแบบ ผู้ที่มี MCI มักเริ่มมีความผิดปกติด้านความจำหรือความคิดบางอย่าง *มากกว่าที่ควรจะเป็นตามวัย* แต่ยังสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง ยังดูแลตนเองได้ ยังทำกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ และยังคงใช้ชีวิตอย่างอิสระ

ทำไม MCI จึงสำคัญ

ในอดีต วงการแพทย์มักให้ความสนใจกับผู้ป่วยเมื่อเข้าสู่ระยะสมองเสื่อมแล้ว แต่ปัจจุบันเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงของสมองอาจเริ่มขึ้นก่อนหน้านั้นหลายปี บางครั้งอาจนานเป็นสิบปี



หน้าต่างแห่งโอกาส

MCI เปรียบเสมือนหน้าต่างแห่งโอกาส — เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถมองเห็นกำลังส่งสัญญาณบางอย่างให้เราเห็น และเป็นช่วงเวลาที่เรายังมีโอกาสลงมือดูแลได้มากที่สุด

MCI คืออัลไซเมอร์หรือไม่

คำตอบคือ **"ไม่เสมอไป"** — นี่เป็นเรื่องสำคัญที่ हमอยากให้คุณทุกคนเข้าใจ คนที่มี MCI ไม่ได้หมายความว่า จะกลายเป็นอัลไซเมอร์ทุกคน บางคนมีอาการคงที่อยู่อ่หลายปี บางคนดีขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อสาเหตุเกิดจากปัจจัยที่แก้ไขได้ เช่น การนอนหลับไม่ดี ภาวะซึมเศร้า ความเครียดเรื้อรัง การขาดวิตามินบางชนิด หรือผลข้างเคียงจากยา

ในขณะเดียวกัน ก็มีบางคนที่ MCI เป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์ และค่อย ๆ พัฒนาไปสู่ภาวะสมองเสื่อมในอนาคต นี่จึงเป็นเหตุผลที่การประเมินโดยละเอียดมีความสำคัญมาก

MCI ในชีวิตจริงหน้าตาเป็นอย่างไร

ผู้ป่วยหลายคนที่มีหอบพบมักพูดคล้ายกันว่า **"หอมรับ ผมรู้สึกว่ตัวเองไม่เหมือนเดิม"** พวกเขาายังทำงานได้ ยังขับรถได้ ยังใช้ชีวิตได้ แต่เริ่มต้องพึ่งการจดบันทึกมากขึ้น เริ่มลืมนัดหมายที่ไม่เคยลืม เริ่มต้องให้คู่สมรสช่วยเตือนเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

และที่สำคัญ พวกเขารับรู้ได้ด้วยตนเองว่าความสามารถบางอย่างกำลังเปลี่ยนไป ในหลายกรณี การรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของตนเองเช่นนี้กลับเป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่าสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ตนเองยังทำงานได้ดี

ข่าวดีที่หลายคนไม่รู้

เมื่อพูดถึงอัลไซเมอร์ ผู้คนมักรู้สึกสิ้นหวัง แต่เมื่อพูดถึง MCI หมออยากให้ทุกท่านคิดต่างออกไป เพราะนี่คือช่วงเวลาที่เรายังสามารถทำอะไรได้อีกมาก — การควบคุมความดันโลหิต การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การนอนหลับที่มีคุณภาพ การเข้าสังคม การกระตุ้นสมอง และการดูแลโรคร่วมต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสุขภาพสมองในระยะยาว

MCI จึงไม่ใช่คำพิพากษา

แต่มักเป็นคำเตือน

และคำเตือนที่ได้รับเร็ว ย่อมมีค่ากว่าคำเตือนที่มาช้าเสมอ

● หมอชวนคิด

หลายคนมองว่า MCI เป็นข่าวร้าย แต่ในอีกมุมหนึ่ง มันอาจเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่สมองกำลังเคาะประตูและบอกเราอย่างสุภาพว่า "ถึงเวลาเริ่มดูแลผมอย่างจริงจังแล้ว"

บางครั้ง สัญญาณเตือนไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อให้เรากลัว แต่ถูกส่งมาเพื่อให้เราเตรียมตัว

● สิ่งที่คุณอยากให้อำ

MCI ไม่ใช่ความจำปกติ แต่ก็ยังไม่ใช่อัลไซเมอร์ เป็นภาวะตรงกลางที่ควรได้รับการประเมินและติดตามอย่างเหมาะสม

การรู้เร็ว ไม่ได้ทำให้โรคเกิดขึ้นเร็ว แต่ช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นในการดูแลสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือคุณภาพชีวิตในอนาคต

ความจำแย่ ไม่ได้แปลว่า เป็นอัลไซเมอร์เสมอไป



หลังจากอ่านมาถึงตรงนี้ ผู้อ่านหลายท่านอาจเริ่มย้อนนึกถึงพ่อแม่ของตนเอง บางคนอาจพบว่าสัญญาณบางอย่างในบทก่อนหน้านี้ ดูคล้ายกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในครอบครัว บางคนอาจเริ่มรู้สึกกังวล และบางคนอาจกำลังถามตัวเองอยู่เงียบ ๆ ว่า **"หรือว่าพ่อแม่กำลังเป็นอัลไซเมอร์"**

หมอเข้าใจความรู้สึกนี้ดี เพราะเป็นคำถามที่หมอพบแทบทุกวันในคลินิกความจำ แต่ก่อนที่เราจะรีบด่วนสรุป หมออยากชวนให้มองความจริงข้อหนึ่งก่อน

**ความจำแย่ลงไม่ใช่ชื่อโรค
แต่เป็นอาการ**

เช่นเดียวกับอาการไข้ — เมื่อมีไข้ เราไม่สามารถบอกได้ทันทีว่าเกิดจากโรคอะไร อาจเป็นไข้หวัด อาจเป็นการติดเชื้อ หรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นอีกหลายอย่าง ความจำที่เปลี่ยนไปก็เช่นเดียวกัน — อาจเกิดจากอัลไซเมอร์ แต่ก็อาจเกิดจากโรคหรือภาวะอื่นที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง และบางสาเหตุสามารถรักษาได้

เรื่องเล่าจากคลินิก: ไม่ใช่อัลไซเมอร์เสมอไป

หมอยังจำคุณครูเกษียณท่านหนึ่งได้ดี ลูกสาวพามาพบหมอด้วยความกังวลเรื่องความจำ เธอเล่าว่าแม่เริ่มลืมนัด ลืมวางของ และดูไม่มีสมาธิเหมือนเดิม ในตอนแรกครอบครัวคิดว่าอาจเป็นอัลไซเมอร์ แต่เมื่อซักประวัติอย่างละเอียด หมอกลับพบรายละเอียดบางอย่างที่น่าสนใจ

คุณครูท่านนี้นอนไม่ค่อยหลับมาหลายเดือน ไม่อยากออกจากบ้าน ไม่อยากพบเพื่อน สิ่งที่เคยชอบทำกลับไม่รู้สึกรักสนุกอีกต่อไป และมักรู้สึกเศร้าโดยไม่มีเหตุผลชัดเจน สุดท้ายสิ่งที่พบไม่ใช่อัลไซเมอร์ แต่เป็น **ภาวะซึมเศร้า** หลังได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาการด้านความจำก็ค่อย ๆ ดีขึ้น

สาเหตุที่พบบ่อย ของความจำแย่ลง



ภาวะซึมเศร้า

เมื่อสมองอยู่ในภาวะซึมเศร้า การจดจำข้อมูลใหม่ การมีสมาธิ และความเร็วในการคิด ล้วนลดลงได้ บางครั้งผู้ป่วยรู้สึกเหมือนความจำเสื่อม ทั้งที่ต้นเหตุสำคัญอยู่ที่ภาวะทางอารมณ์



การนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพ

เมื่อสมองไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ความสามารถในการสร้างและจัดเก็บความทรงจำก็ลดลง สมองเหมือนห้องทำงานที่ใช้เวลากลางคืนจัดเก็บเอกสาร หากการนอนถูกรบกวน การจัดระเบียบก็ทำได้ไม่เต็มที่



การขาดวิตามินบี 12 และโรคไทรอยด์

วิตามินบี 12 มีความสำคัญต่อระบบประสาทอย่างมาก เมื่อขาดเป็นเวลานาน ผู้ป่วยอาจมีอาการหลงลืม สมาธิลดลง ขาดตามปลายมือปลายเท้า ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ก็สามารถทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้บ่อยลง — ภาวะเหล่านี้รักษาได้



โรคหลอดเลือดสมองขนาดเล็ก

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันสูง และการสูบบุหรี่ สามารถทำร้ายเส้นเลือดเล็ก ๆ ในสมองอย่างเงียบ ๆ ผู้ป่วยอาจไม่เคยมี

อัมพาตชัดเจน แต่ความเสียหายเล็ก ๆ สะสมจนกระทบความคิด การวางแผน และความจำ



ยาบางชนิด

ยานอนหลับ ยาคลายกังวล หรือยาแก้แพ้บางชนิดอาจส่งผลต่อความจำ สมาธิ หรือความคิด โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ — ไม่ได้แปลว่าควรหยุดยาเอง แต่ควรแจ้งรายการยาทั้งหมดให้แพทย์ทราบ

การวินิจฉัยคือการต่อจิ๊กซอว์

สิ่งที่หมออยากให้คุณเห็นจากร่องรอยทั้งหมดนี้ก็คือ อัลไซเมอร์เป็นเพียงหนึ่งในหลายสาเหตุของความจำที่เปลี่ยนไป บางสาเหตุรักษาได้ บางสาเหตุป้องกันได้ และบางสาเหตุจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

การวินิจฉัยโรคความจำไม่ใช่การเดาจากความรู้สึก แต่เป็นการต่อจิ๊กซอว์หลายชิ้นเข้าด้วยกัน ทั้งประวัติอาการ การตรวจร่างกาย การประเมินความจำ ผลตรวจเลือด และในบางกรณีอาจรวมถึงการตรวจสมองเพิ่มเติม ยิ่งเข้าใจสาเหตุได้ถูกต้องมากเท่าไร โอกาสในการดูแลรักษาก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

● หมอชวนคิด

หลายครั้ง สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การได้รับการวินิจฉัย แต่คือการคิดเอาเองโดยที่ยังไม่รู้ความจริง เพราะเมื่อเราไม่รู้คำตอบ ความกลัวมักเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นเสมอ

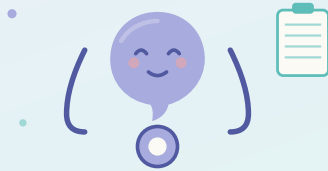
และบางครั้ง สิ่งที่เรากังวลว่าเป็นอัลไซเมอร์ อาจเป็นภาวะที่สามารถรักษาได้

● สิ่งที่คุณอยากรู้ให้จำ

ความจำที่เปลี่ยนไปเป็นสัญญาณที่ควรใส่ใจ แต่ไม่ควรรีบด่วนสรุปอัลไซเมอร์เป็นเพียงหนึ่งในหลายสาเหตุของปัญหาด้านความจำ การประเมินอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญ

เพราะก่อนจะถามว่า "เป็นอัลไซเมอร์หรือไม่" เราควรถามก่อนว่า "เกิดอะไรขึ้นกับสมองของคนที่เรารักกันแน่"

ถ้าสงสัยพ่อแม่มีปัญหา ความจำ ควรตรวจอะไรบ้าง



มีคำถามหนึ่งที่ลูกหลานมักถามหมอ หลังจากเล่าความเปลี่ยนแปลงของพ่อแม่ให้ฟัง "หมอครับ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแม่เป็นอัลไซเมอร์จริงหรือเปล่า"

บางคนถามด้วยความกังวล บางคนถามด้วยความกลัว และบางคนลังเลมานานหลายเดือนกว่าจะตัดสินใจพาพ่อแม่มาตรวจ เพราะลึก ๆ แล้ว พวกเขากลัวคำตอบ

หมอเข้าใจความรู้สึกนี้ดี สำหรับหลายครอบครัว คำว่า "ตรวจอัลไซเมอร์" ฟังดูเหมือนกำลังเดินเข้าไปหาข่าวร้าย แต่ในความเป็นจริง การตรวจความจำไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นโรค

เป้าหมายที่สำคัญกว่านั้นคือเพื่อทำความเข้าใจว่า "เกิดอะไรขึ้นกับสมองของคนที่เรารัก"

การวินิจฉัยเริ่มจากการฟัง

หลายคนคิดว่าการตรวจสมองต้องเริ่มจากเครื่องมือราคาแพง ต้องเริ่มจากเอกซเรย์ ต้องเริ่มจากเครื่อง MRI แต่ความจริงแล้ว เครื่องมือแรกที่สำคัญที่สุดของแพทย์คือ "เรื่องราว"

หมอมักเริ่มจากการฟัง — อาการเริ่มตั้งแต่เมื่อไร เปลี่ยนแปลงเร็วหรือช้า ลืมเรื่องประเภทไหน ยังทำกิจกรรมเดิมได้หรือไม่ มีปัญหาเรื่องอารมณ์ การนอน หรือพฤติกรรมร่วมด้วยหรือเปล่า เพราะโรคสมองแต่ละชนิดมีรูปแบบของมันเอง เหมือนรอยเท้าที่แตกต่างกัน หน้าที่ของแพทย์คือค่อย ๆ อ่านรอยเท้าเหล่านั้น

ทำไมหมอต้องถามลูกหลาน

มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนแปลกใจเวลามาตรวจความจำ นั่นคือหมอมักอยากคุยกับคนในครอบครัวด้วย ไม่ใช่เพราะไม่เชื่อผู้ป่วย แต่เพราะธรรมชาติของโรคความจำบางชนิด ทำให้ผู้ป่วยอาจไม่รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของตนเองทั้งหมด

บางคนรู้สึกว่าตนเองยังเหมือนเดิม แต่คนใกล้ชิดกลับเห็นรายละเอียดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน เช่น แม่ถามเรื่องเดิมบ่อยขึ้น พ่อเริ่มจัดการเงินผิดพลาด เริ่มลืมนัดสำคัญ หรือทำสิ่งที่เคยทำได้ยากขึ้น

ข้อมูลเหล่านี้มีค่ามาก เพราะคนในครอบครัวคือคนที่เห็น "ชีวิตจริง" ของผู้ป่วย ไม่ใช่เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ในห้องตรวจ

แบบทดสอบความจำคืออะไร

หลังจากซักประวัติ แพทย์มักประเมินการทำงานของสมองด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน หลายคนกังวลเวลาต้องทำแบบทดสอบ บางคนพูดก่อนเริ่มว่า "หมอครับ ผมกลัวสอบตก"

แต่หมอมักบอกเสมอว่า — นี่ไม่ใช่การสอบ ไม่มีผ่านหรือไม่ผ่าน ไม่มีเก่งหรือไม่เก่ง แต่เป็นเหมือนการตรวจสอบสุขภาพของสมอง เหมือนเราวัดความดันเพื่อดูหัวใจ หรือตรวจน้ำตาลเพื่อดูเบาหวาน แบบทดสอบความจำช่วยให้เราเห็นการทำงานของสมองหลายด้าน เช่น ความจำ สมาธิ ภาษา การคิดวิเคราะห์ การวางแผน เพราะสมองไม่ได้มีหน้าที่จำเพียงอย่างเดียว

ตรวจเลือด และภาพสมอง

หลังจากอ่านบทก่อนหน้านี้ ท่านคงเห็นแล้วว่าความจำที่แย่งไม่ได้เกิดจากอัลไซเมอร์เท่านั้น ดังนั้นบางครั้งหมอจึงจำเป็นต้องตรวจเลือดเพิ่มเติม เพื่อค้นหาสาเหตุอื่น เช่น ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ การขาดวิตามินบางชนิด หรือความผิดปกติของระบบร่างกายอื่น ๆ เพราะบางครั้งปัญหาที่ดูเหมือนเกิดจากสมอง อาจมีต้นเหตุจากสิ่งที่รักษาได้

ส่วนการตรวจ MRI สมอง ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกคน แต่ในบางสถานการณ์ ภาพถ่ายสมองมีประโยชน์อย่างมาก เพราะช่วยให้แพทย์มองเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นจากภายนอก เช่น ร่องรอยของโรคหลอดเลือดสมอง เนื้องอกบางชนิด น้ำคั่งในสมองบางภาวะ หรือรูปแบบการฝ่อของสมองบางตำแหน่ง การตรวจภาพสมองจึงไม่ได้มีไว้เพื่อ "หาอัลไซเมอร์อย่างเดียว" แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้มองข้ามสาเหตุอื่นที่สำคัญ

ตรวจแล้วได้อะไร

บางครอบครัวบอก हमว่า "ถ้าเป็นอัลไซเมอร์แล้วยังรักษาไม่หาย จะตรวจไปทำไม" นี่เป็นคำถามที่ดีมาก แต่ हमอยากชวนมองอีกมุมหนึ่ง

เราไม่ได้ตรวจเพียงเพื่หาคำว่า "หาย" หรือ "ไม่หาย" เราตรวจเพื่อให้มี **เวลา** — เวลาในการดูแล เวลาในการวางแผน เวลาในการปรับชีวิต และเวลาในการรักษาคุณภาพชีวิตให้นานที่สุด

หลายครอบครัวที่รู้เร็ว สามารถเตรียมตัวได้ดีกว่า เข้าใจผู้ป่วยมากกว่า และลดความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่เข้าใจ บางครั้งการรู้คำตอบไม่ได้เปลี่ยนอดีต แต่มันเปลี่ยนวิธีที่เราจะเดินต่อไปในอนาคต

● หมอชวนคิด

การตรวจความจำไม่ใช่การค้นหาว่าใคร "ผิดปกติ" แต่คือการฟังว่าสมองกำลังบอกอะไรเรา

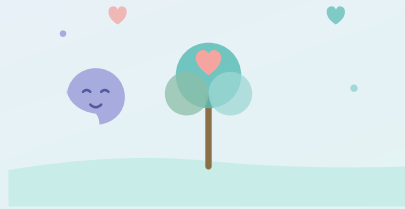
เพราะสมองก็เหมือนร่างกายส่วนอื่น ยิ่งเราเข้าใจมันเร็ว เรายังมีโอกาสดูแลมันได้ดีขึ้น

● สิ่งที่หมออยากให้อำ

ถ้าคนที่เรารักเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงด้านความจำ อย่ารอนทนทุกอย่างชัดเจนเกินไป การมาตรวจเร็วไม่ได้แปลว่าโรครุนแรง แต่แปลว่าเรายังมีโอกาสค้นหาสาเหตุ วางแผน และดูแลสมองตั้งแต่วันที่ยังทำอะไรได้อีกมาก

เพราะบางครั้ง คำตอบที่ได้เร็วขึ้น อาจหมายถึงเวลาคุณภาพที่เพิ่มขึ้นของทั้งครอบครัว

ถ้าเป็นอัลไซเมอร์จริง เรายังทำอะไรได้บ้าง



มีช่วงเวลาหนึ่งในห้องตรวจที่หมอรู้สึกที่สำคัญมาก ไม่ใช่ช่วงที่อธิบายผลตรวจ ไม่ใช่ช่วงที่อธิบายชื่อยา แต่เป็นช่วงเวลาหลังจากที่ครอบครัวได้ยินคำว่า **"โรคอัลไซเมอร์"** เป็นครั้งแรก

บางคนเงียบ บางคนน้ำตาคลอ บางคนพยายามถามคำถามต่อทันทีเพื่อซ่อนความกังวล แต่หมอรู้ดีว่าในใจของหลายคนกำลังมีคำถามเดียวกัน **"หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น"** และบางครั้งคำถามที่อยู่ลึกกว่านั้นคือ **"เรากำลังจะเสียคนที่เรารักไปหรือเปล่า"**

ความรู้สึกนี้เป็นเรื่องธรรมดามาก เพราะสำหรับคนส่วนใหญ่ คำว่าอัลไซเมอร์ไม่ได้หมายถึงแค่โรค แต่มันเชื่อมโยงกับภาพของการสูญเสีย ความทรงจำ การพึ่งพาคนอื่น และการเปลี่ยนแปลงของคนที่เรารัก

แต่สิ่งแรกที่คุณมักบอกครอบครัวคือ การได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น อัลไซเมอร์ ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของทุกอย่าง แต่มันคือจุดเริ่มต้นของการดูแลอย่างเข้าใจมากขึ้น

อัลไซเมอร์เป็นโรคที่ค่อย ๆ เติบโต

หลายคนคิดว่าเมื่อเป็นอัลไซเมอร์แล้ว ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่ในความเป็นจริง โรคนี้มักดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผู้ป่วยจำนวนมาก โดยเฉพาะในระยะแรก ยังสามารถใช้ชีวิตได้อีกหลายอย่าง ยังพูดคุยได้ ยังหัวเราะได้ ยังทำกิจกรรมที่ชอบได้ ยังมีช่วงเวลาที่มีความหมายกับครอบครัวได้

สิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าโรคอยู่ในระยะใด และควรวางแผนดูแลอย่างไร เพราะการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่ใช่การรอให้ความสามารถหายไป แต่คือการช่วยรักษาความสามารถที่ยังเหลืออยู่ให้นานที่สุด

ยารักษาอัลไซเมอร์ช่วยอะไร

คำถามที่คุณมักได้รับบ่อยคือ "มียารักษาให้หายไหม" คำตอบในปัจจุบันคือ เรายังไม่มียาที่ทำให้อัลไซเมอร์หายขาด แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีอะไรทำ

ยาที่ใช้ในปัจจุบันมีเป้าหมายเพื่อช่วยประคับประคองการทำงานของสมอง ช่วยให้สารสื่อประสาทบางชนิดทำงานดีขึ้น และในผู้ป่วย

บางรายอาจช่วยให้ความคิด ความจำ หรือการใช้ชีวิตประจำวันคงอยู่ได้นานขึ้น



เปรียบกับการเดินขึ้นเขา

ถนนบางสายอาจมีความชันมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ยานี้ไม่ได้เปลี่ยนภูเขาให้หายไป แต่บางครั้งมันช่วยให้เราเดินบนเส้นทางนั้นได้ดีขึ้นและนานขึ้น

การรักษาไม่ได้มีแค่ยา

นี่เป็นสิ่งที่หมออยากเน้นมาก เพราะหลายครอบครัวให้ความสำคัญกับคำถามว่า *"มียาอะไร"* จนลืมถามว่า *"เราจะดูแลชีวิตของเขาอย่างไร"*

สมองไม่ได้ต้องการเพียงยา แต่ต้องการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จำนวนมากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อครอบครัวเข้าใจวิธีดูแล เช่น จัดกิจวัตรประจำวันที่สม่ำเสมอ ส่งเสริมให้ทำสิ่งที่ยังทำได้ ออกกำลังกาย พูดคุย เข้าสังคม นอนหลับอย่างเหมาะสม และลดสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียดหรือสับสน บางครั้งสิ่งเล็กๆ เหล่านี้มีผลต่อชีวิตประจำวันมากกว่าที่หลายคนคิด

อย่ารีบเอาทุกอย่างออกจากชีวิตผู้ป่วย

เมื่อรู้ว่าคนที่รักเป็นอัลไซเมอร์ หลายครอบครัวทำด้วยความหวังดี แต่บางครั้งกลับรับช่วยมากเกินไป — ไม่ให้ทำอาหาร ไม่ให้ทำงานบ้าน ไม่ให้ตัดสินใจอะไรเอง เพราะกลัวผิดพลาด

แน่นอนว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ แต่ผมอยากให้จำไว้ว่า **ความสามารถของมนุษย์เหมือนกล้ามเนื้อ สิ่งที่ไม่ได้ใช้ มักอ่อนแรงเร็วขึ้น** เป้าหมายของการดูแลไม่ใช่การทำทุกอย่างแทน แต่คือการช่วยให้ผู้ป่วยทำสิ่งที่ยังทำได้ต่อไปให้นานที่สุด

รักคน ไม่ใช่รักษาแค่ความจำ

มีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมาก คนเราไม่ได้มีคุณค่าเพราะจำทุกอย่างได้ เราไม่ได้รักพ่อแม่เพราะท่านจำวันเกิดเราได้ ไม่ได้รักเพราะท่านจำรายละเอียดทุกเหตุการณ์ในอดีตได้ แต่เรารักเพราะเรื่องราวทั้งหมดที่เคยสร้างร่วมกันมา

แม้บางความทรงจำในสมองของผู้ป่วยจะค่อย ๆ เลือนหาย แต่ความสัมพันธ์ ความรู้สึก และความหมายของชีวิตยังคงอยู่ หลายครั้งผู้ป่วยอาจจำไม่ได้ว่าเมื่อวานลูกมาเยี่ยม แต่ยังรู้สึกอบอุ่นเมื่อเห็นหน้าลูกวันนี้ — **สมองอาจลืมเหตุการณ์ แต่หัวใจของมนุษย์ยังรับรู้ความรักได้**

● หมอชวนคิด

อัลไซเมอร์อาจทำให้คนหนึ่งลืมบางเรื่องราวในชีวิต แต่ไม่ได้ทำให้คุณค่าของชีวิตนั้นลดลง

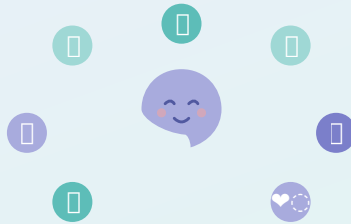
เพราะมนุษย์เป็นมากกว่าความทรงจำที่เรา มี เราเป็นความรัก ความสัมพันธ์ และความหมายที่เราเคยสร้างไว้กับคนรอบตัว

● สิ่งที่หมออยากให้อำ

การวินิจฉัยอัลไซเมอร์ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนดูแลอย่างถูกต้อง

รู้เร็ว — เข้าใจเร็ว — ปรับตัวเร็ว ช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นในการรักษาสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่เพียงความจำ แต่คือคุณภาพชีวิตและช่วงเวลาที่มีความหมายร่วมกันของครอบครัว

7 เคล็ดลับดูแลสมอง ลดความเสี่ยงสมองเสื่อม



หลังจากดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาหลายปี มีคำถามหนึ่งที่หมอได้รับบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ใช่จากผู้ป่วย แต่จากลูกหลานที่นั่งอยู่ข้าง ๆ หลังจากพาคุณพ่อหรือคุณแม่มาตรวจ หลังจากเห็นสิ่งที่โรคอัลไซเมอร์ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนในครอบครัว หลายคนหันมาถามหมอด้วยคำถามเดียวกัน "หมอครับ แล้วเราจะป้องกันตัวเองได้ไหม"

คำถามนี้สะท้อนความจริงอย่างหนึ่ง เมื่อเราเห็นคนที่เรารักเจ็บป่วย เรามักเริ่มมองย้อนกลับมาที่ตัวเอง เราเริ่มสงสัยว่าสมองของเราจะเป็นอย่างไรในอีกสิบปี ยี่สิบปีข้างหน้า เราจะยังจำเรื่องราวสำคัญในชีวิตได้หรือไม่ เราจะยังสามารถดูแลตัวเอง และใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้หรือเปล่า

คำตอบของหมอคือ เราอาจไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ เราไม่สามารถเลือกพันธุกรรมที่ได้รับมา และไม่สามารถหยุดเวลาที่ผ่านไป แต่เราสามารถดูแลสมองของเราได้มากกว่าที่หลายคนคิด

สมองในอนาคต เริ่มสร้างตั้งแต่วันนี้

หลายคนเริ่มสนใจสุขภาพสมอง เมื่อวันที่สมองเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างออกมาแล้ว แต่ความจริงคือ การดูแลสมองควรเริ่มก่อนวันนั้นนานมาก

หมอมักเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ — ต้นไม้ที่แข็งแรงพอจะยืนหยัดในวันที่เจอพายุ ไม่ได้เกิดจากการรีบรดน้ำในวันที่พายุมา แต่มาจากการดูแลรากของมันเป็นอย่างสม่ำเสมอตลอดหลายปีที่ผ่านมา สมองก็เช่นเดียวกัน สิ่งเล็ก ๆ ที่เราทำทุกวัน — อาหารที่เราเลือก จำนวนก้าวที่เราเดิน คุณภาพของการนอน วิธีจัดการความเครียด และความสัมพันธ์กับคนรอบตัว ทั้งหมดค่อย ๆ สะสมและกลายเป็นสุขภาพสมองของเราในอนาคต

1

ขยับร่างกาย ให้สมองแข็งแรง

สิ่งที่ติดหัวใจ มักติดสมองด้วย สมองต้องการเลือดและออกซิเจนตลอดเวลา การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ช่วยดูแลหลอดเลือดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้สมอง —

เราไม่ได้ออกกำลังกายเพียงเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงในวันนี้ แต่เพื่อให้สมองยังคงเดินทางไปกับเราได้อีกนานในอนาคต

2

เลือกอาหาร เพื่อบำรุงสมองระยะยาว

อาหารที่เน้นผัก ผลไม้ ธัญพืช ปลา ไขมันที่ดี และลดอาหารแปรรูป เป็นรูปแบบที่มีการศึกษาว่าสัมพันธ์กับสุขภาพสมองที่ดี แต่อาหารไม่ใช่ข้อสอบ — เป็นวิถีชีวิต อาหารที่ดีที่สุดคืออาหารที่ดีพอ และเราสามารถทำต่อเนื่องได้จริง

3

เรียนรู้สิ่งใหม่ ให้สมองไม่หยุดเติบโต

สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการการใช้งาน — การอ่านหนังสือ เรียนรู้ทักษะใหม่ เล่นดนตรี ฝึกภาษา หรือทำกิจกรรมที่ท้าทายความคิด เป็นเหมือนการออกกำลังกายให้เครือข่ายของสมองสำคัญไม่ใช่แค่ทำกิจกรรมเยอะ แต่คือการเปิดโอกาสให้สมองได้เจอสิ่งใหม่

4

ดูแลสุขภาพกาย เพื่อปกป้องสมอง

สมองไม่ได้แยกออกจากร่างกาย โรคต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ หากไม่ได้รับการดูแล อาจค่อย ๆ ส่งผลต่อหลอดเลือดเล็ก ๆ ในสมอง การดูแลตัวเลขสุขภาพเหล่านี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการป้องกันโรคทางกาย แต่เป็นการลงทุนเพื่อสมองในอนาคต

5

นอนให้พอ ให้สมองได้ฟื้นฟู

ในอดีต หลายคนคิดว่าการนอนคือเวลาที่สมองหยุดพัก แต่ปัจจุบันเรารู้ว่าสมองยังทำงานอย่างมากระหว่างการนอนหลับ — ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่สมองจัดระเบียบข้อมูล ฟื้นฟูระบบต่าง ๆ และเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ การนอนที่ดีจึงไม่ใช่ความขี้เกียจ แต่เป็นหนึ่งในกิจกรรมดูแลสมองที่สำคัญที่สุด

6

ดูแลใจ ลดความเครียดของสมอง

สมองและจิตใจไม่เคยแยกจากกัน ความเครียดเรื้อรัง ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า สามารถส่งผลกระทบต่อสมาธิ ความจำ และคุณภาพชีวิตได้ หลายครั้งสิ่งที่สมองต้องการ ไม่ใช่ข้อมูลเพิ่มเติม แต่คือพื้นที่ให้พักและฟื้นตัว การดูแลใจจึงเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสมอง

7

เชื่อมต่อผู้คน เติมพลังให้สมอง

มนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่เพียงลำพัง บทสนทนา เสียงหัวเราะ ความสัมพันธ์ และความรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่า ล้วนเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งของสมอง บางครั้งการพูดคุยกับคนที่เรารักหนึ่งมื้ออาหาร อาจกระตุ้นสมองหลายด้านมากกว่าที่เราคิด เพราะสมองไม่ได้ต้องการเพียงข้อมูล แต่ต้องการความหมาย

เมื่อมองทั้ง 7 เคล็ดลับรวมกัน เราจะพบว่าสิ่งที่ช่วยดูแลสมองไม่ใช่เรื่องไกลตัว หลายอย่างเป็นสิ่งธรรมดาที่เราารู้อยู่แล้ว แต่สิ่งธรรมดาเหล่านี้ เมื่อทำอย่างต่อเนื่อง อาจกลายเป็นสิ่งพิเศษสำหรับสมองในอนาคต

● หมอชวนคิด

สมองที่ดีในวัย 70 หรือ 80 ปี ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในวันเกิดครบรอบ 70 ปี แต่ถูกสร้างจากสิ่งเล็กๆ ๗ ที่เราทำซ้ำมาตลอดชีวิต

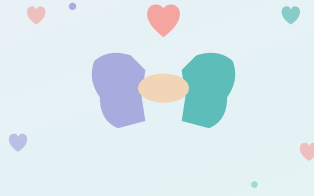
ทุกมื้ออาหาร ทุกก้าวเดิน ทุกคืนที่นอนหลับ และทุกความสัมพันธ์ที่เรารักษาไว้ ล้วนเป็นการลงทุนให้สมองของเราในอนาคต

● สิ่งที่เหมาะสมให้จำ

เราอาจเลือกพันธุกรรมไม่ได้ เราอาจหยุดเวลาไม่ได้ แต่เราสามารถเลือกวิธีดูแลสมองของเราได้ตั้งแต่วันนี้

เป้าหมายของการดูแลสมอง ไม่ใช่เพียงการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น แต่คือการรักษาคุณภาพของวันที่เรายังมีอยู่ — ให้เป็นวันที่เรายังคิดได้ จำได้ รักได้ และเป็นตัวเราได้นานที่สุด

เมื่อพ่อแม่เริ่มหลงลืม ลูกหลานควรดูแลอย่างไร



มีคำถามหนึ่งที่หมอได้รับบ่อยมากจากลูกหลานของผู้ป่วย แต่คำถามนี้ไม่ได้เกี่ยวกับยา ไม่ได้เกี่ยวกับผลตรวจสมอง และไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขคะแนนความจำ คำถามนั้นคือ "หมอครับ ผมควรทำตัวยังไงกับพ่อดี" หรือ "หมอกะ หนูควรพูดกับแม่ยังไงดี"

หลายครั้งคำถามเหล่านี้ไม่ได้มาจากความไม่รู้เท่านั้น แต่มาจากความรัก ความเหนื่อย ความกังวล และบางครั้งก็มีความรู้สึกผิดซ่อนอยู่ เพราะการดูแลคนที่เรารักซึ่งกำลังเปลี่ยนไป ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเมื่อคนคนนั้นคือพ่อแม่ คนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นฝ่ายดูแลเรามาทั้งชีวิต

วันที่บทบาทเริ่มเปลี่ยนไป

ในวัยเด็ก พ่อแม่คือคนที่จำทุกอย่างแทนเรา จำวันที่เราต้องไปโรงเรียน จำอาหารที่เราชอบ จำสิ่งที่เรากลัว และจำรายละเอียดเล็ก ๆ ในชีวิตของเราได้มากกว่าที่เราจำตัวเองเสียอีก วันที่เรายังเดินไม่มั่นคง ท่านจับมือเราไว้ วันที่เรายังไม่เข้าใจโลกใบนี้ ท่านค่อย ๆ พาเราเรียนรู้

แต่หลายสิบปีผ่านไป วันหนึ่งบทบาทนั้นอาจค่อย ๆ เปลี่ยนไป จากคนที่เคยได้รับการดูแล กลายเป็นคนที่เริ่มดูแล จากคนที่เคยถาม กลายเป็นคนที่คอยตอบคำถามเดิมซ้ำ ๆ จากมือเล็ก ๆ ของเราที่เคยจับมือพ่อแม่ กลายเป็นมือของพ่อแม่ที่กำลังต้องการให้เราจับกลับ การเปลี่ยนบทบาทนี้ไม่ง่ายสำหรับใครเลย ไม่ง่ายสำหรับลูก และไม่ง่ายสำหรับพ่อแม่เช่นกัน

อย่ามองเหินแค่สิ่งที่หายไป

เมื่อคนที่เรารักเริ่มมีปัญหาความจำ ธรรมชาติของเรามักทำให้เรามองเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไป แม่ถามซ้ำอีกแล้ว พ่อลืมนัดอีกแล้ว สิ่งที่เคยทำได้ กลับเริ่มทำได้ยากขึ้น โดยไม่รู้ตัว เราอาจเริ่มมองคนที่เรารักผ่านสิ่งที่โรคพรากไป

แต่ हमอยากชวนให้มองอีกด้านหนึ่ง **ยังมีอีกหลายอย่างที่ยังอยู่** รอยยิ้มยังอยู่ ความรู้สึกยังอยู่ ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยังอยู่ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ยังอยู่ โรคอาจเปลี่ยนความสามารถบางอย่าง แต่ไม่ได้เปลี่ยนคุณค่าของคนคนหนึ่ง

ชวนทบทวนความทรงจำ ไม่ใช่ทดสอบความจำ

หลายครอบครัวถามกันว่า "เราควรถามเรื่องเก่า ๆ กับท่านไหม" หรือ "ควรชวนท่านนึกหรือเปล่า" คำตอบคือ ถามได้ครับ และหลายครั้ง การพูดคุยทบทวนความทรงจำเป็นสิ่งที่ดีมาก

การชวนพ่อแม่เล่าเรื่องวัยเด็ก เรื่องสมัยทำงาน สถานที่ที่เคยไป หรือช่วงเวลาที่มีความสุข อาจเป็นการกระตุ้นสมอง และที่สำคัญกว่านั้น คือเป็นการเชื่อมโยงใจของคนในครอบครัวเข้าหากัน หมอเคยเห็นผู้ป่วยหลายคนที่ย้ำเหตุการณ์ใหม่ได้ไม่ดี แต่เมื่อเล่าถึงเรื่องราวในอดีต ดวงตากลับมีประกาย มีรอยยิ้ม และเต็มไปด้วยความภูมิใจ

แต่สิ่งสำคัญคือ ให้สังเกตความรู้สึกของคนตรงหน้า ถ้าเราถามแล้ว ท่านยิ้ม สนุกกับการเล่า รู้สึกภูมิใจที่ได้แบ่งปันเรื่องราว นั้นไม่ใช่การทดสอบ แต่มันคือของขวัญ แต่หากวันหนึ่งคำถามเดิมทำให้ท่านกังวล นิ่ง พยายามหาคำตอบแต่หาไม่เจอ หรือเริ่มเสียความมั่นใจ เราอาจเปลี่ยนวิธี

✗ "จำได้ไหมว่าเมื่อวานใครมาเยี่ยม"

✓ "เมื่อวานลูก ๆ มาเยี่ยมกัน สนุกมากเลยนะครับ"

บางครั้งเราไม่ได้ถามเพื่อวัดว่าท่านจำได้แค่ไหน แต่เราเล่าไปด้วยกัน เพื่อพาท่านกลับไปสัมผัสความรู้สึกดี ๆ อีกครั้ง

อย่าเถียงเพื่อเอาชนะโรค

เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในหลายบ้าน แม่บอกว่า "ยังไม่ได้กินข้าวเลย" ทั้งที่เพิ่งรับประทานไปไม่นาน ลูกตอบทันทีว่า "กินแล้วไงแม่จำไม่ได้หรอก" ลูกพูดถูก แต่บางครั้งการพูดถูกไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น เพราะสำหรับผู้ป่วย สิ่งที่เขารับรู้ในเวลานั้นคือความจริงของเขา

การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมไม่ใช่การแข่งขันว่าใครจำเหตุการณ์ได้แม่นยำกว่า แต่คือการเดินเข้าไปในโลกของเขาด้วยความเข้าใจ บางครั้งเป้าหมายไม่ใช่การชนะข้อเท็จจริง แต่คือการรักษาความสัมพันธ์

ให้ผู้ป่วยยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า

หนึ่งในความกลัวลึก ๆ ของผู้ป่วยจำนวนมากคือ กลัวกลายเป็นภาระ กลัวไม่มีประโยชน์ กลัวไม่ใช่คนเดิมในสายตาของครอบครัว ดังนั้นสิ่งเล็ก ๆ จึงมีความหมาย — ให้อยู่ช่วยพับผ้า รดน้ำต้นไม้ เลือกเมนูอาหาร เล่าเรื่องเก่า ๆ หรือทำกิจกรรมที่ยังทำได้ สิ่งเหล่านี้กำลังบอกเขาว่า "คุณยังสำคัญ"

คนดูแลก็ต้องได้รับการดูแล

หลายครั้งลูกหลานทุ่มเททุกอย่างให้ผู้ป่วย จนลืมดูแลตัวเองเหนื่อย เครียด พักผ่อนไม่พอ และรู้สึกผิดเวลาที่ตัวเองรู้สึกเหนื่อย แต่การดูแลระยะยาวต้องใช้พลังใจอย่างมาก การพักจึงไม่ใช่ความเห็นแก่

ตัว แต่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแล เพราะผู้ดูแลที่ยังมีแรง คือของขวัญ
สำคัญสำหรับผู้ป่วยเช่นกัน

ช่วงเวลาของการส่งคืนความรัก

มีประโยคหนึ่งที่ลูกหลานบางคนเคยพูดกับหมอหลังจากช่วงเวลา
ของการดูแลพ่อแม่ไปสักระยะ "ตอนแรกคิดว่านี้คือช่วงเวลาที่ยากที่สุด
แต่สุดท้ายกลับรู้สึกขอบคุณที่ยังมีเวลานี้"

เพราะหากมองย้อนกลับไป ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นฝ่ายได้รับ — วันที่
เราเดินไม่ได้ มีมือของพ่อแม่คอยประคอง วันที่เราร้องไห้ มีอ้อมกอด
ของท่านคอยปลอบ วันที่เราไม่รู้จักรักโลก มีท่านคอยเดินอยู่ข้าง ๆ วันนี้
เมื่อเวลาหมุนกลับ เราอาจได้เป็นฝ่ายจับมือท่านบ้าง

การดูแลพ่อแม่ในวันที่ท่านอ่อนแอลง จึงไม่ใช่เพียงหน้าที่ แต่อาจ
เป็นหนึ่งในโอกาสพิเศษของชีวิต โอกาสที่จะได้ส่งคืนความรัก ความ
อดทน และความเอาใจใส่ที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้รับมาอย่างมากมาย เรา
ไม่จำเป็นต้องดูแลทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ เราเพียงแค่อ้อย ๆ เดินไป
กับท่าน เหมือนที่ครั้งหนึ่ง ท่านเคยเดินช้า ๆ เพื่อรอเรา

● หมอชวนคิด

วันที่พ่อแม่จำบางเรื่องไม่ได้ อาจเป็นวันที่ลูกต้องช่วยจำแทนว่า ครั้งหนึ่งท่านเคยจำทุกอย่างเพื่อเรา

วันที่ท่านเดินช้าลง อาจเป็นวันที่เรามีโอกาสเดินช้าลง เพื่อเดินไปพร้อมกับท่าน

เพราะสุดท้ายแล้ว สิ่งที่เราากำลังดูแล อาจไม่ใช่เพียงความทรงจำ แต่คือความรักทั้งหมดที่อยู่ระหว่างทางของชีวิต

● สิ่งที่หมออยากให้อ่าน

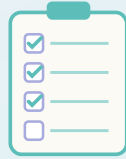
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์อาจลืมเหตุการณ์บางอย่าง แต่ยังรับรู้ความรัก ความอบอุ่น และความรู้สึกปลอดภัยได้

อย่ามองผู้ป่วยเป็นเพียงโรค ให้มองเขาเป็นคนคนเดิม คนที่เคยรักเรา ดูแลเรา และเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตเรา

เพราะวันหนึ่ง ความทรงจำบางหน้าอาจเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ความรักที่เราเคยมอบให้กัน จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว นั้นเสมอ

Brain Care Toolkit

เครื่องมือดูแลสมองสำหรับคนที่คุณรัก



**"เพราะการดูแลสมองที่ดี
ไม่ได้เริ่มจากวันที่เรารู้คำตอบ
แต่เริ่มจากวันที่เราสังเกตด้วยความเข้าใจ"**

เครื่องมือที่ 1 — พ่อแม่ควรตรวจความจำหรือยัง?

ลองสังเกตในช่วง 6-12 เดือนที่ผ่านมา ว่าท่านมีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่

☐ ถามคำถามเดิม หรือเล่าเรื่องเดิมซ้ำบ่อยขึ้น

☐ สับสนจุดหมาย หรือเหตุการณ์สำคัญ

☐ วางของผิดที่และหาไม่เจอบ่อยขึ้น

☐ เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่เคยทำได้ เช่น โทรศัพท์ การเงิน ทำอาหาร

☐ จัดการยา เงิน หรือเอกสารผิดพลาด

☐ หลงทางในสถานที่ที่เคยคุ้นเคย

☐ หาคำพูดลำบาก ใช้คำผิดมากขึ้น

☐ อารมณ์ บุคลิก หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไป

☐ เลิกสนใจกิจกรรมที่เคยชอบ

☐ คนใกล้ตัวรู้สึกว่ "ไม่เหมือนเดิม"

ไม่มีข้อใดเลย — ดูแลสมองต่อ

เนื่อง

ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจพบได้ตามวัย แต่สมองยังต้องการการดูแลทุกวัน

พบ 1-2 ข้อ — เริ่มสังเกตอย่าง

ใส่ใจ

ลองบันทึกเหตุการณ์จริง และติดตามการเปลี่ยนแปลงในอีก 2-3 เดือน

พบหลายข้อ หรือเริ่มกระทบชีวิตประจำวัน — ควรประเมิน

เพิ่ม

เป้าหมายไม่ใช่เพื่อติดป้ายว่าเป็นโรค แต่เพื่อเข้าใจว่า "สมองกำลังต้องการความช่วยเหลืออะไร"

เครื่องมือที่ 2 — ชวนพ่อแม่มาตรวจความจำอย่างไร เมื่อท่าน กลัวหรือไม่อยากพบแพทย์

หลายครั้งเมื่อพูดเรื่องตรวจความจำ เราอาจได้ยินว่า "ไม่ได้เป็นอะไร" หรือ "แก่แล้วก็ลืมแบบนี้แหละ" ก่อนพยายามอธิบายเหตุผล ให้เข้าใจก่อนว่า — เบื้องหลังคำปฏิเสธ อาจไม่ใช่ความดี แต่อาจเป็น **ความกลัว** — กลัวเสียความสามารถ กลัวเป็นภาระ กลัวชีวิตไม่เหมือนเดิม

✗ "แม่ลืมมากแล้ว ต้องไปตรวจ"

✓ "เราไปเช็คสุขภาพสมองกันดีไหม เหมือนตรวจสุขภาพประจำปี"

✗ "พ่ออาจเป็นอัลไซเมอร์"

✓ "ลองไปดูว่ามีอะไรที่ช่วยให้สมองทำงานดีขึ้นได้ไหม"

✗ "บอกแล้วว่าลืมหลายครั้ง"

✓ "ลูกเป็นห่วง อยากให้เราช่วยกันดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ"

เทคนิคสำคัญ — ใช้คำว่า **ตรวจสอบสุขภาพสมอง** มากกว่า "ตรวจอัลไซเมอร์" / ใช้คำว่า **เราไปด้วยกัน** ไม่ใช่ "พ่อ/แม่ต้องไป" / เริ่มจากสิ่งที่ท่านรู้สึก เช่น นอนไม่ดี เวียนหัว / เน้นว่า "รู้เร็ว = มีโอกาสดูแลมากขึ้น"

เครื่องมือที่ 3 — เตรียมตัวก่อนพบแพทย์ด้านความจำ

การตรวจความจำที่ดี เริ่มจากข้อมูลชีวิตจริง — ก่อนพบแพทย์ ลองเตรียมคำตอบเหล่านี้

- ☐ เริ่มสังเกตอาการตั้งแต่เมื่อไร
- ☐ ใครเป็นคนสังเกตเห็นก่อน
- ☐ ตัวผู้ป่วยรู้สึกที่ตัวเองเปลี่ยนไปหรือไม่
- ☐ ตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่ทำให้กังวลคืออะไร
- ☐ อาการค่อย ๆ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนเร็ว
- ☐ ยังจัดการชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมหรือไม่
- ☐ อารมณ์ บุคลิก หรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปไหม
- ☐ การนอนเป็นอย่างไร
- ☐ ใช้ยาอะไรอยู่ และมีโรคประจำตัวอะไร
- ☐ สิ่งที่ครอบครัวยังกังวลมากที่สุดคืออะไร

● หมอชวนคิด

ไม่มีใครอยากถูกพาไปตรวจ เพราะรู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียบางอย่าง

แต่ทุกคนอยากได้รับการดูแล เมื่อรู้ว่ายังมีคนเดินไปด้วยกัน

● สิ่งที่หมออยากให้อำ

การมาพบแพทย์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ป่วย แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจสมอง และการดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุด

ความทรงจำอาจเปลี่ยนไป แต่ความรักยังคงอยู่



ถ้าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้มาจนถึงหน้านี้ บางทีคุณอาจเป็นลูกคนหนึ่ง
หนึ่งที่เริ่มสังเกตเห็นว่าพ่อแม่ไม่เหมือนเดิม บางทีคุณอาจเป็นคู่ชีวิตที่กำลัง
เป็นห่วงคนที่เดินทางร่วมกันมาหลายสิบปี หรือบางทีคุณอาจเป็นคน
หนึ่งที่เริ่มอยากดูแลสมองของตัวเองให้ดีที่สุด

ไม่ว่าคุณเริ่มต้นอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยเหตุผลอะไร หมออยากบอก
ว่า การที่คุณเริ่มตั้งคำถาม คือก้าวแรกของการดูแลแล้ว

หลายครั้งสิ่งที่ทำให้ครอบครัวกลัวที่สุด อาจไม่ใช่แค่คำว่า
"อัลไซเมอร์" แต่คือความรู้สึกว่าเรากำลังค่อย ๆ สูญเสียคนที่เรารักไป

แต่จากประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยจำนวนมาก หมอได้เรียนรู้ว่าคน
หนึ่งคนไม่ได้ประกอบขึ้นจากความจำเพียงอย่างเดียว เราทุกคน

ประกอบขึ้นจากเรื่องราวที่เคยมีร่วมกัน ความรักที่เคยมอบให้กัน เสียง
หัวเราะ ช่วงเวลาธรรมดา ๆ ในครอบครัว และความหมายที่เรามีต่อกัน

โรคสมองเสื่อมอาจทำให้บางความทรงจำเลือนหาย แต่ไม่ได้ลบ
คุณค่าของชีวิตหนึ่งชีวิต ไม่ได้ลบความเป็นพ่อ ไม่ได้ลบความเป็นแม่ ไม่
ได้ลบคนที่ครั้งหนึ่งเคยจับมือเรา ในวันที่เราเดินไม่มั่นคง

ตลอดหลายปีในการเป็นแพทย์ดูแลผู้ป่วยโรคสมอง หมอพบว่า
ครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยได้ดีที่สุด ไม่ใช่ครอบครัวที่รู้ทุกคำตอบ ไม่ใช่
ครอบครัวที่ทำทุกอย่างสมบูรณ์แบบ แต่คือครอบครัวที่พยายามเข้าใจ
และพร้อมปรับตัวไปพร้อมกับคนที่เขารัก

ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่หมออยากให้นักเรียนเล่มนี้ฝากไว้ ไม่ใช่เพียงว่าเราจะ
รู้จักอัลไซเมอร์มากขึ้น แต่คือ **เราจะกลัวมันน้อยลง เพราะความเข้าใจ**

วันที่พ่อแม่เริ่มถามเรื่องเดิม ขอให้เราจำไว้ว่า ครั้งหนึ่งท่านเคย
ตอบคำถามเดิมของเราเป็นร้อยครั้ง วันที่ท่านเดินช้าลง ขอให้เราจำไว้
ว่า ครั้งหนึ่งท่านเคยเดินช้าลงเพื่อรอเรา วันที่ท่านต้องการความ
ช่วยเหลือมากขึ้น อาจเป็นวันที่ชีวิตให้ออกาสเรา ได้ส่งคืนความรักบาง
ส่วน ที่เราเคยได้รับมาอย่างมากมาย

แน่นอนว่าเส้นทางนี้อาจไม่ง่าย มีวันที่เหนื่อย มีวันที่กังวล และมี
วันที่ไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร แต่คุณไม่จำเป็นต้องเดินบนเส้นทางนี้เพียง
ลำพัง ความรู้ ครอบครัว และทีมดูแลสุขภาพ สามารถเดินไปด้วยกันได้

● หมอชวนคิดเป็นครั้งสุดท้าย

บางทีเป้าหมายของการดูแลสุขภาพ อาจไม่ใช่เพียงการรักษาความ
ทรงจำทุกอย่างไว้ตลอดไป แต่อาจเป็นการรักษาความหมายของ
ช่วงเวลาที่เรายังมีร่วมกัน ให้ดีที่สุด

"วันหนึ่ง

ความทรงจำบางส่วนอาจเลือนหายไปตามกาลเวลา

แต่ความรัก ความผูกพัน

และเรื่องราวที่เราเคยสร้างร่วมกัน

จะยังคงเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเสมอ"

นพ.อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ

อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา

เกี่ยวกับผู้เขียน

หมอผู้ดูแล สมองและความทรงจำ



นพ.อดิศักดิ์ กิตติสารเศ

Adisak Kittisares, M.D.

อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา
(Neurologist) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ประสาท ความจำ ภาวะสมองเสื่อม
และโรคอัลไซเมอร์

นพ.อดิศักดิ์ กิตติสารเศ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท
ให้การดูแลผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท โดยมีความสนใจเฉพาะ

ด้านการดูแลสุขภาพสมอง ความจำ ภาวะสมองเสื่อม และโรคอัลไซเมอร์

ปัจจุบันปฏิบัติงานด้านประสาทวิทยา ณ โรงพยาบาลศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นผู้ก่อตั้ง "คลินิกรักษาสมอง หมออดิศักดิ์" ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยโรคทางสมองแบบองค์รวม ตั้งแต่การประเมินความผิดปกติของสมอง การรักษา การป้องกัน และการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล

ประวัติการศึกษาและวุฒิปัตร

- แพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วุฒิปัตรสาขาอายุรศาสตร์
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
- วุฒิปัตรอนุสาขาสหสาขาประสาทวิทยา
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

โรคสมองเสื่อม & อัลไซเมอร์

ประเมิน&ดูแลปัญหาความจำ

การป้องกันสมองเสื่อม

โรคหลอดเลือดสมอง

ปวดศีรษะ & ไมเกรน

โรกระบบประสาททั่วไป

เรียนรู้โรคสมองเพิ่มเติมได้ที่

www.dradisak.com

ช่องทางติดตามความรู้ด้านสมอง

□ ความรู้ด้านความจำ สมองเสื่อม และอัลไซเมอร์

FACEBOOK

สมองเสื่อมต้องรู้ โดยหมอดิศักดิ์

สัญญาณเตือนโรคสมองเสื่อม • โรคอัลไซเมอร์ • การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาความจำ • คำแนะนำสำหรับครอบครัวและผู้ดูแล

□ ความรู้โรคสมองและระบบประสาททั่วไป

FACEBOOK

หมอดิศักดิ์ รัชส์มอง

YOUTUBE

หมอดิศักดิ์ รัชส์มอง

เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพสมอง โรคทางระบบประสาท และแนวทางดูแลสมอง
ในชีวิตประจำวัน

"เพราะการดูแลสมอง
ไม่ใช่เพียงการรักษาความจำ
แต่คือการดูแลคุณภาพชีวิต เรื่องราว
และคุณค่าของคนหนึ่งคน"

